SULFADIAZINA BASE

SINÔNIMOS/NOME QUÍMICO: ***Solfadiazina; Solfapirimidina; Sulfadiatsiini; Sülfadiazin; Sulfadiazin; Sulfadiazina; Sulfadiazinas; Sulfadiazinum; Sulphadiazine; Szulfadiazin; N1-(Pyrimidin-2-yl)sulphanilamide.***

FÓRMULA MOLECULAR: $C_{10}H_{10}N_4O_2S$

PESO MOLECULAR: 250.3

CAS: 68-35-9

DCB: 08116

INFORMAÇÕES GERAIS: a sulfadiazina faz parte do grupo das sulfonamidas, (ANVISA, 2007).

MECANISMO DE AÇÃO: é um antibiótico sistêmico e seu mecanismo de ação é dado pela inibição competitiva da síntese do ácido fólico pelas bactérias; bacteriostático (BRASIL, 2006).

INDICAÇÃO: é a droga de escolha no tratamento da toxoplasmose, associado a pirimetamina, e como alternativa na malária por *P. falciparum* sensível ou resistente à cloroquina (ANVISA, 2007).

É a sulfonamida de eleição para o tratamento de nocardiose. Também é utilizada no tramento do linfogranuloma venéreo e na profilaxia da febre reumática recorrente, em

pacientes alérgicos à penicilina (BATISTUZZO, J. A. D. O., 2015).
Está indicada também para: Infecção cancróide, tracoma e infecções no trato urinário (BRASIL, 2006).

FAIXA DE DOSAGEM USUAL:

Público em geral:
Adultos: os adultos devem usar de 2 a 4 g, inicialmente, como dose de ataque, seguida de 2 a 4 g por dia, divididas em 3 a 6 doses.

Crianças: crianças acima de 2 meses podem receber dose de ataque de 75 mg/kg ou 2 g/m², seguida de 150 mg/kg ou 4 g/m² diários, divididos a cada 4 – 6 horas. A dose pediátrica não pode ultrapassar 6 g.

Em portadores de AIDS:
Adultos: para prevenção a longo prazo da recorrência da toxoplasmose em pacientes adultos portadores de AIDS, recomenda-se 0,5 a 1 g de sulfadiazina a cada 6 horas, associada a pirimetamina (25 a 75 mg/dia) e ácido folínico (10 a 25 mg/dia). O tratamento de manutenção deve ser suspenso se contagem de CD4 > 200 durante pelo menos 6 meses após o fim do tratamento, na ausência de sintomas.

Crianças: nas crianças portadores da síndrome, a profilaxia da recorrência da toxoplasmose é feita com doses de 85 a 120 mg/kg/dia em 2 a 4 tomadas, associada a pirimetamina (1 mg/kg/dia — máximo de 25 mg por dose) e ácido folínico (5 mg a cada 3 dias).

Administrada com outros fármacos:
Pirimetamina: quando usada em conjunto com a pirimetamina, a dose de sulfadiazina é de 1 a 1,5 g de 6 em 6 horas em adultos e de 100 a 200 mg/kg/dia em crianças. A duração do tratamento é de 3 a 6 semanas (BRASIL, 2006).

SUGESTÕES DE FÓRMULA:

Sulfadiazina (cápsulas):

Sulfadiazina ..... 500 mg
Excipientes qsp ..... 1 cápsula
Mande ..... cápsulas

Sulfadiazina (suspensão):
Sulfadiazina ..... 100 mg
Suspensão oral qsp..... 1 mL
Mande em frasco com ..... mL
(BATISTUZZO, J. A. D. O., 2015)

EFEITOS ADVERSOS:

Mais comuns: incluem febre, erupções cutâneas, dermatite esfoliativa, fotossensibilidade, urticária, náuseas, vômitos, diarreia, estomatite, conjuntivite, artrite e hepatite.
Incomuns: Síndrome de Stevens-Johnson.
Raros: Poliarterite nodosa e psicose.

Efeitos no trato urinário: a sulfadiazina pode provocar cristalúria quando administrada em grandes doses, sobretudo se a ingestão hídrica for deficiente.

Efeitos hematopoiéticos: Sulfonamidas podem provocar anemia hemolítica ou aplástica, granulocitopenia, trombocitopenia ou reações leucemoides. As sulfonamidas podem provocar reações hemolíticas em pacientes com deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase (KATZUNG G. B., 2017).

ADVERTÊNCIAS:

Na amamentação: uso criterioso durante a amamentação. Não há dados sobre segurança para uso durante o período da lactação (BRASIL, 2010). É possivelmente compatível (GIUGLIANI, E. R. J. et al., 2017).

Na gravidez: risco B*/D**
*Estudos de reprodução animal não demonstraram risco fetal,

mas não há estudos controlados no ser humano; ou estudos em reprodução animal demonstraram efeitos adversos que não foram confirmados em estudos controlados no ser humano nos vários trimestres.
**Há evidência positiva de risco fetal humano, porém, os benefícios do uso em gestantes podem ser aceitáveis (SILVA, H, et al., 2012).

INTERAÇÕES:

Antibacterianos: Existe sinergismo aditivo entre a sulfadiazina + sulfamerazina + sulfametazina (SILVA, P., 2010).

Medicamentos com sulfonamidas: Historicamente, medicamentos contendo uma fração de sulfonamida, incluindo sulfas antimicrobianas, diuréticos, diazóxido e os agentes hipoglicemiantes sulfanilureias, eram considerados alergênicos cruzados. Contudo, evidências recentes sugerem que a reação cruzada é rara (KATZUNG G. B., 2017).

Outras interações: Interações relatadas com 2–anticoagulantes, 2–ciclosporina, 2–metotrexato, 3–hidantoína, 3–metenamina, 3–PABA (BRASIL, 2006).

FARMACOCINÉTICA E FARMACODINÂMICA:

Biodisponibilidade: É absorvida pelo trato gastrointestinal após a aplicação oral, distribuindo-se amplamente nos tecidos, atingindo níveis terapêuticos nos líquidos cefalorraquidiano, sinovial, pleural e peritoneal. Atinge concentrações máximas no sangue entre 4-8 h (KATZUNG G. B., 2017; ANVISA, 2007).
A administração de uma dose de 3 g de sulfadiazina resulta em concentrações plasmáticas máximas de 50 micrograma/mL (SILVA, P., 2010). As concentrações terapêuticas das sulfonamidas estão na faixa de 40 a 100 mcg/mL de sangue (KATZUNG G. B., 2017). Apresentam alta ligação proteica (ANVISA, 2007).

Metabolismo: uma parte do fármaco absorvido é acetilada ou glicuronizada no fígado.

Meia vida: intermediária (10-17 h) (KATZUNG G. B., 2017).

Excreção: é excretada por via renal (SILVA, P., 2010), principalmente por filtração glomerular (KATZUNG G. B., 2017). De 15% a 40% da droga excretada encontra-se na forma acetilada, que sofre excreção mais rápida que a fração livre (SILVA, P., 2010).

REFERÊNCIAS:

ANTIMICROBIANOS - BASES TEÓRICAS E USO CLÍNICO. Disponível em:<https://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/rede_rm/cursos/rm_controle/opas_web/modulo1/sulfonamidas5.htm>. Acesso em: 23 nov. 2022.

BATISTUZZO, J. A. D. O; ITAYA, Masayuki; ETO, Yukiko. Formulário Médico Farmacêutico. 5. ed. São Paulo: Atheneu, 2015.

BRASIL, Ministério da Saúde; ATENÇÃO À SAÚDE, SECRETARIA DA. Amamentação e uso de medicamentos e outras substâncias. 2. ed. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2010. p. 1-92.

BRASIL, Ministério da Saúde; CRUZ, Fundação Oswaldo. Memento terapêutico: (Série B. Textos Básicos de Saúde). 8. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. p. 1-302.

GIUGLIANI, E. R. J. et al. Uso de medicamentos e outras substâncias pela mulher durante a amamentação. Sociedade Brasileira de Pediatria, Rio de Janeiro, RJ, n. 4, p. 1-18, ago/2022. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/Aleitamento_-__Uso_Medicam_durante_Amament.pdf. Acesso em: 6 dez. 2022.

KATZUNG G. B; Organizador Associado, Anthony J. Trevor; Farmacologia básica e clínica [recurso eletrônico] / [tradução: Ademar Valadares Fonseca ... et al.; revisão técnica: Almir Lourenço da Fonseca]. – 13. ed. – Porto Alegre: AMGH, 2017.

SILVA, H. M. E. M. E. D. M. D. M. A. PROTOCOLO DE PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS E TERAPÊUTICOS DA CLÍNICA DE OBSTETRÍCIA. 4. ed. Vila Nova Cachoeirinha - SP:

[s.n.], 2012. p. 1-755.

SILVA, P; Farmacologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.

Texto atualizado em 18/12/2022, por Andreia e Milena.

As informações contidas em nossas literaturas são fornecidas de boa-fé, fundamentadas no conhecimento atual sobre o assunto e têm valor apenas indicativo. Quaisquer informações, inclusive as sugestões de utilização dos produtos, não devem dispensar ensaios e verificações experimentais, essenciais para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. Também é responsabilidade do farmacêutico observar a legislação local e obter todas as autorizações necessárias e não se deve dispensar o correto diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento

Dúvidas: São Paulo: 11 3577-9750 | Demais regiões: 0800 7046407